

手足口病诊疗指南

一、疾病定义与病因

1.1 疾病定义

手足口病（HFMD）是由肠道病毒引起的急性发热出疹性传染病，以手、足、口腔等部位出现皮疹、疱疹和溃疡为典型特征。多发生于 5 岁以下儿童，全年均可发病，夏秋季为高峰。多数患儿症状轻微，一周左右自愈，少数可并发无菌性脑膜炎、脑干脑炎、神经源性肺水肿等严重并发症。

1.2 主要病因

病原体主要为肠道病毒，其中以柯萨奇病毒 A16 型（Cox A16）和肠道病毒 71 型（EV71）最为常见。EV71 所致手足口病重症比例和死亡率显著高于其他型别。

传播途径：

- 粪-口传播：接触被病毒污染的玩具、餐具、水源。
 - 呼吸道飞沫传播：咳嗽、打喷嚏。
 - 密切接触传播：接触患儿疱疹液、分泌物。
-

二、典型症状与体征

2.1 普通病例表现

1. 发热：多为低至中度发热（38℃左右），持续 1-3 天。
2. 皮疹与疱疹：
 - 口腔：咽峡部、软腭、颊黏膜出现散在灰白色疱疹或红色小溃疡，周围绕以红晕，疼痛明显，患儿常因口腔疼痛而拒食、流涎。
 - 手、足：手掌、足底出现斑丘疹，后转为圆形或椭圆形小疱疹，疱壁厚、疱液少，不易破溃。
 - 臀部及四肢：臀部、膝部也可出现类似皮疹。
3. 全身症状：部分患儿可伴咳嗽、流涕、食欲不振、恶心呕吐。

2.2 重症病例早期识别（关键!）

若出现以下任一项，提示可能发展为重症，必须立即住院：

- 持续高热（体温>39℃）超过 3 天。

- 精神差：嗜睡、易惊、烦躁不安、肢体抖动。
 - 呼吸异常：呼吸增快（>30-40 次/分）、呼吸节律不整。
 - 循环障碍：面色苍白、四肢凉、心率增快、毛细血管再充盈时间延长（>2 秒）。
 - 神经系统：头痛、呕吐、颈项强直、眼球震颤。
-

三、诊断标准与检查方法

3.1 诊断标准

根据流行病学史、典型皮疹分布（手、足、口、臀）及发热，临床即可诊断。不典型病例需结合病原学检查。

3.2 辅助检查

检查项目	目的与临床意义
血常规	白细胞总数正常或降低，重症病例可升高。
病原学检查	咽拭子或粪便标本 EV71、Cox A16 核酸检测（金标准）。
血清学检查	EV71-IgM 抗体检测，用于早期诊断。
脑脊液检查	疑诊中枢神经系统受累时，可见白细胞数轻度增高，蛋白正常或轻度增高。
胸部 X 线	重症病例排查肺水肿、肺出血。

四、治疗方案（包括常用药物）

4.1 普通病例治疗（居家隔离为主）

手足口病无特效抗病毒药，以对症支持治疗为主。

治疗方向	常用药物及措施
口腔护理	进食前后用温盐水或康复新液漱口，疼痛剧烈者可用利多卡因凝胶涂于溃疡面（饭前 5-10 分钟）。
退热	体温 $>38.5^{\circ}\text{C}$ 时口服布洛芬或对乙酰氨基酚。
抗病毒	可试用干扰素 α 喷雾剂局部喷咽峡部，早期应用有一定疗效。
皮疹护理	保持皮肤清洁干燥，疱疹破溃处涂抹莫匹罗星软膏（百多邦）预防继发细菌感染。
营养支持	给予清淡、温凉流质或半流质饮食（如牛奶、稀粥、果汁），避免酸、辣、烫食物刺激口腔。

4.2 重症病例治疗（住院治疗）

- 降颅压：甘露醇静脉滴注，防治脑水肿。
- 糖皮质激素：甲泼尼龙冲击治疗，抑制过度炎症反应。
- 免疫球蛋白：静脉注射用人免疫球蛋白（IVIG），中和病毒、调节免疫。
- 呼吸循环支持：必要时机械通气、血管活性药物。

五、家庭护理与预防建议

5.1 家庭护理要点

1. 隔离：患儿应居家隔离至症状消失后 1 周（自发病起不少于 2 周），不与其他儿童接触。
2. 口腔护理：鼓励多饮温水，减轻口腔疼痛，防止脱水。
3. 皮肤护理：剪短指甲，避免抓破疱疹；臀部有皮疹时保持干燥，便后清洗。
4. 消毒：患儿餐具、毛巾、玩具煮沸或含氯消毒液浸泡，被褥暴晒。

5.2 预防措施

1. 疫苗接种：EV71 灭活疫苗已上市，适用于 6 月龄-5 岁儿童，接种 2 剂次（间隔 1 个月），可有效预防 EV71 感染所致手足口病，大幅降低重症和死亡风险。
2. 切断传播：流行季节少去儿童密集的公共场所，不接触患病儿童。

3. 手卫生：教会儿童正确洗手（七步洗手法），饭前便后、外出回家后必须洗手。
4. 环境通风：居室每日开窗通风 2-3 次，每次不少于 30 分钟。